

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ISCA · INTERROGATORIO SISTEMATIZADO DE CONSUMOS ALCOHÓLICOS

Protocolo cuantitativo en Unidades de Bebida Estándar (UBE) para la detección precoz de consumo de riesgo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA)
Autores Originales	Antoni Gual, M. Contel, L. Segura, A. Ribas y Joan Colom (Grup GAB, 2001)
Ámbito y Desarrollo	Programa «Beveu Menys» / Generalitat de Catalunya y Socidrogalcohol (España)
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica semiestructurada breve de cuantificación de consumo en UBE
Población Diana	Población adulta (≥ 16 años) atendida en atención primaria, urgencias y medicina del trabajo
Tiempo de Aplicación	2 a 3 minutos (integrado en la anamnesis clínica habitual)
Formato de Respuesta	Registro cuantitativo directo de consumos diferenciando días laborables y fines de semana
Finalidad Clínica	Identificación precoz de bebedores de riesgo y consumo episódico intensivo (binge drinking) antes de que se instaure daño orgánico o dependencia física

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La inmensa mayoría de las personas con consumos perjudiciales de alcohol no presentan rasgos evidentes de alcoholismo marginal ni acuden a centros monográficos de drogodependencias. Suelen ser atendidos en centros de salud familiar por patologías intercurrentes (hipertensión arterial, dispepsia, hipertransaminasemia o insomnio), donde la pregunta tradicional “¿Usted bebe mucho?” fracasa estrepitosamente debido a respuestas evasivas y normalización sociocultural del consumo.

El ISCA fue concebido por el grupo de Gual en el marco del programa preventivo de salud pública para sistematizar la cuantificación del etanol ingerido mediante el concepto unificado de **Unidad de Bebida Estándar (UBE)**, equivalente en España a 10 gramos de alcohol puro (1 cerveza o 1 copa de vino = 1 UBE; 1 copa de licor o combinado = 2 UBE). El modelo discrimina con rigor el consumo regular durante los días laborables del patrón de atracón concentrado en fines de semana, permitiendo una clasificación objetiva del nivel de riesgo.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Parámetro de Registro	Fórmula	Contenido Clínico y Sistemática de Pregunta
Consumo Laborable (L-J)	Días x UBE/día	¿Qué suele beber de lunes a jueves? (desayuno, aperitivo, comida, tarde y cena).
Consumo Fin de Semana	Días x UBE/día	¿Qué suele beber los viernes, sábados y domingos? (aperitivos, copas nocturnas).
Consumo Semanal Total	Suma Total UBE	Total UBE semanales = (Consumo laborable x 4) + (Consumo fin de semana x 3).
Consumo Máximo por Ocasión	UBE en una sentada	Identificación de consumo intensivo concentrado (≥ 5 UBE en varones o ≥ 4 en mujeres).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · ISCA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 86.4% y Especificidad = 91.2% para identificar bebedores de riesgo en atención primaria en España (Gual et al., 2001).
Concordancia con Biomarcadores	Correlación estadísticamente significativa con la gamma-glutamyl transferasa (GGT, $r = 0.56$) y el volumen corpuscular medio (VCM, $r = 0.48$).
Validez Concurrente	Concordancia excelente con el cuestionario AUDIT ($kappa = 0.76$) y con diarios prospectivos de consumo de 7 días ($r = 0.89$).
Factibilidad Asistencial	Aplicable en más del 95% de las consultas ordinarias de atención médica en menos de 2 minutos sin interferir en el flujo de trabajo.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

1. Conversión Inmediata a UBE (10 g de etanol):

- 1 Caña de cerveza (200-250 ml) o 1 vaso de vino / cava (100 ml) = **1 UBE**.
- 1 Copa de licor, carajillo o combinado / cubata (50 ml de destilado 40°) = **2 UBE**.
- 1 Cubata doble o jarra de cerveza (500 ml) = **2 a 4 UBE**.

2. Cálculo de UBEs Semanales:

- Multiplicar las UBE diarias promedio de días laborables por los días de consumo (ej. 4 días).
- Multiplicar las UBE diarias promedio de fin de semana por los días de consumo (ej. 3 días).
- Sumar ambos valores para obtener el total semanal de UBE.

3. Identificación de Consumo en Atracón (Binge Drinking): Registro de episodios de ingesta concentrada rápida (≥ 5 UBE en varones o ≥ 4 UBE en mujeres en menos de 2 horas).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Categoría de Consumo	Varones (UBE/sem)	Mujeres (UBE/sem)	Acción Clínica Recomendada
Bajo Riesgo	≤ 20 UBE / semana	≤ 10 UBE / semana	Refuerzo positivo y consejo sobre límites de seguridad.
Consumo de Riesgo	21 a 40 UBE / sem.	11 a 24 UBE / sem.	Intervención Breve en Atención Primaria y seguimiento a 3 meses.
Consumo Perjudicial / Alto	> 40 UBE / semana	> 24 UBE / semana	Evaluación diagnóstica de dependencia (EIDA/CAGE) y derivación CAD.
Binge Drinking	≥ 5 UBE en una sesión	≥ 4 UBE en una sesión	Consejo preventivo sobre accidentes, violencia e intoxicación aguda.

LÍMITES OFICIALES DE RIESGO SANITARIO (MINISTERIO DE SANIDAD / OMS): Los umbrales actualizados de seguridad establecen que cualquier consumo superior a 20 UBE semanales en varones o 10 UBE en mujeres incrementa significativamente la mortalidad cardiovascular, el cáncer digestivo y los trastornos neuropsiquiátricos. No existe un consumo de alcohol completamente libre de riesgo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · ISCA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación Rutinaria en Anamnesis: Preguntar por consumo cronológico en días laborables y festivos.

Paso 2: Intervención Asistencial Estructurada:

- **Consumo de Bajo Riesgo:** Felicitar al paciente y recordar límites en embarazo y conducción.
- **Consumo de Riesgo (Varones 21-40, Mujeres 11-24 UBE/sem):**
 1. Entregar folleto psicoeducativo de equivalencias de UBE.
 2. Aplicar Intervención Breve de 5 minutos: señalar relación con hipertensión/peso y acordar pacto de reducción de consumo a límites seguros.
 3. Reevaluar en 3 a 6 meses con control de transaminasas.
- **Consumo Perjudicial o Dependencia (> 40 UBE en varones o > 24 en mujeres):** Descartar temblor matutino y derivar a Unidad de Conductas Adictivas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 48 años, comercial de ventas, acude a revisión de salud laboral donde se detecta cifras de tensión arterial de 155/95 mmHg y GGT = 85 U/L. Afirma beber "lo normal, lo social".

Evaluación Sistemática con ISCA:

- **Días Laborables (Lunes a Jueves):** Toma 2 cañas de cerveza en el aperitivo de la comida (2 UBE) y 2 copas de vino en la cena con clientes (2 UBE) = 4 UBE/día x 4 días = 16 UBE.
- **Fines de Semana (Viernes a Domingo):** Viernes noche 3 combinados (6 UBE); sábado aperitivo de 2 vermouths (2 UBE) y cena con 1 cubata (2 UBE); domingo 2 cervezas (2 UBE) = 12 UBE.
- **Total Semanal ISCA:** 28 UBE / semana (Consumo de Riesgo Elevado; límite máximo 20).

Intervención: Se desglosó el cálculo de las 28 UBEs ante el paciente, quien mostró sorpresa al no percibir que consumía casi 300 gramos de alcohol puro semanales. Se realizó una intervención motivacional breve pactando sustituir las cervezas del aperitivo por versiones 0,0% y eliminar los combinados del fin de semana, fijando un objetivo de < 10 UBE/semana. A los 3 meses, el ISCA se redujo a 8 UBE/semana, normalizándose las cifras de presión arterial a 125/80 mmHg y la GGT a 32 U/L sin requerir fármacos antihipertensivos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SALUD

- En mujeres embarazadas, lactancia o conducción no existe umbral seguro: el consumo debe ser estrictamente cero (0 UBE).
- El consumo intensivo en atracón (> 6 UBE) multiplica por 5 el riesgo de arritmias cardíacas paroxísticas ("corazón de fiesta").

FACTORES DE DISTORSIÓN

- **Infradeclaración:** La sospecha de consumo mayor al declarado exige contrastar con familiares y biomarcadores séricos (CDT y GGT).
- **Patología Hepática Previa:** En cirrosis o hepatitis C, cualquier consumo está contraindicado médicamente.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Gual, A., Contel, M., Segura, L., Ribas, A., & Colom, J. (2001). El ISCA (Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos), un nuevo instrumento para la identificación precoz de bebedores de riesgo. *Medicina Clínica*, 117(18), 685–689.
- Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G. (2001). *AUDIT: Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol: Pautas para su utilización en atención primaria*. Organización Mundial de la Salud.
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). *Límites de consumo de bajo riesgo de alcohol: Actualización del consenso clínico en España*. Gobierno de España.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.